Movilidad social y salud

Rodolfo De la Torre

Febrero, 2026

LA SALUD DE LAS PERSONAS

¿ESTÁ DETERMINADA POR SUS CONDICIONES DE ORIGEN?

Respuesta con base en la encuesta **ESRU-EMOVI**

Centro de Estudios®
Espinosa Yglesias

Se **imputa a las personas sus años de vida esperados** de acuerdo a sus características socioeconómicas

Se calculan sus **años *totales* de vida esperados** es decir su edad más los **años de vida esperados**

Más años de vida esperados se asocian a una **mayor salud**. La **esperanza de vida al nacer** es un ejemplo.

EL EJEMPLO DE LA ESPERANZA DE VIDA AL NACER 2025

- La esperanza de vida depende de condiciones **socieconómicas** personales como **la educación o el ingreso**, pero también de su **entorno**

- México tiene una esperanza de vida al nacer de **75.5 años**. Japón tiene la máxima con **85 años**. México tiene el **88.8%** de lo máximo posible.

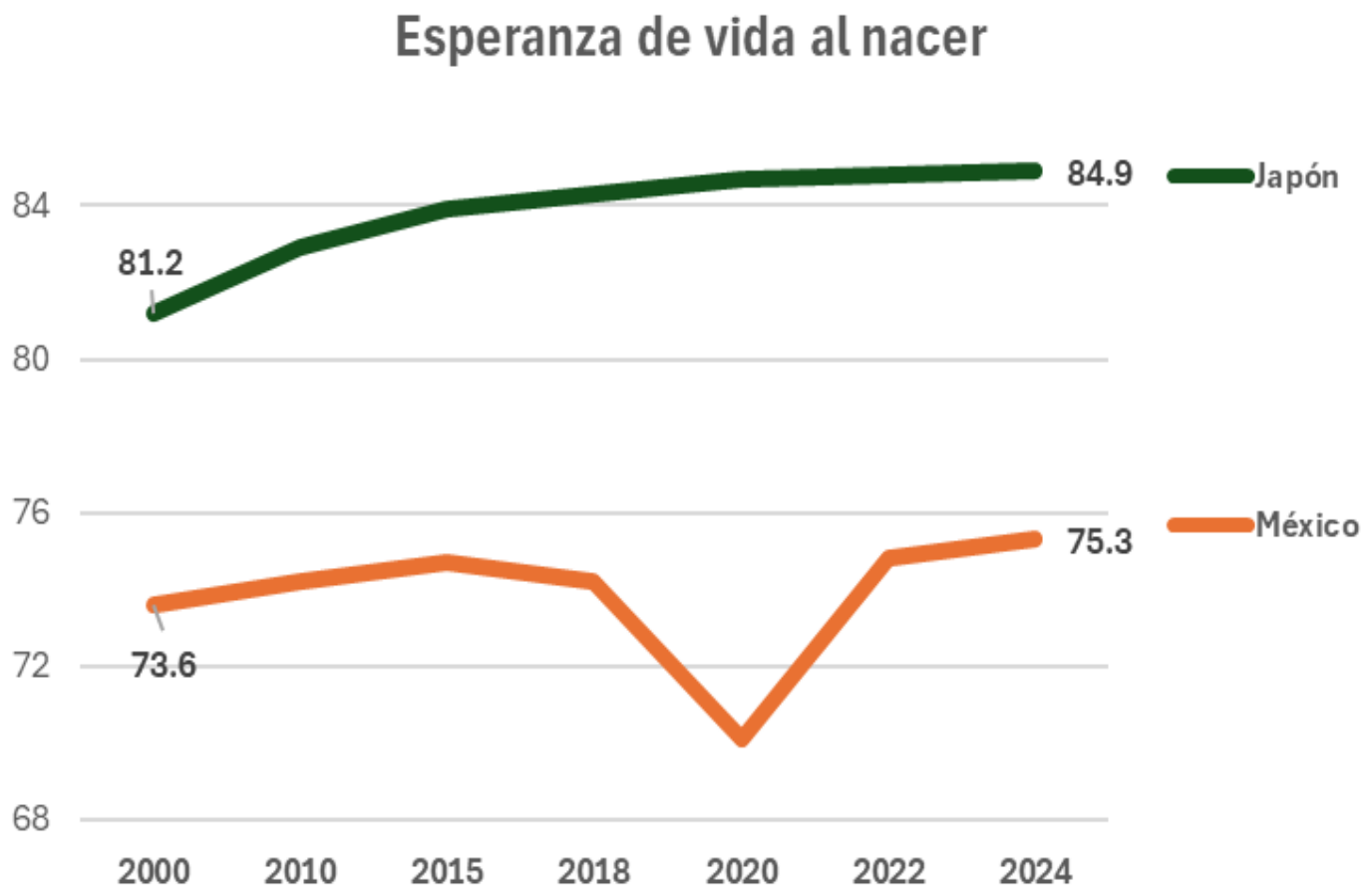
- El **porcentaje de la máxima vida esperada** es un indicador comparativo de salud. Hay diferencias notables entre **grupos socioeconómicos**

Fuente: https://population.un.org/dataportal/data/indicators/61/locations/484,392/start/2000/end/2025/table/pivotbylocation?df=9ae3c7c9-4b2e-4437-9940-9d0e64dbe547

LA ESPERANZA DE VIDA SE ALEJA DE LOS VALORES MÁXIMOS

Casi 10 años

separan a México de la mayor esperanza de vida en el mundo, en 1990 esa distancia era menor a 8 años

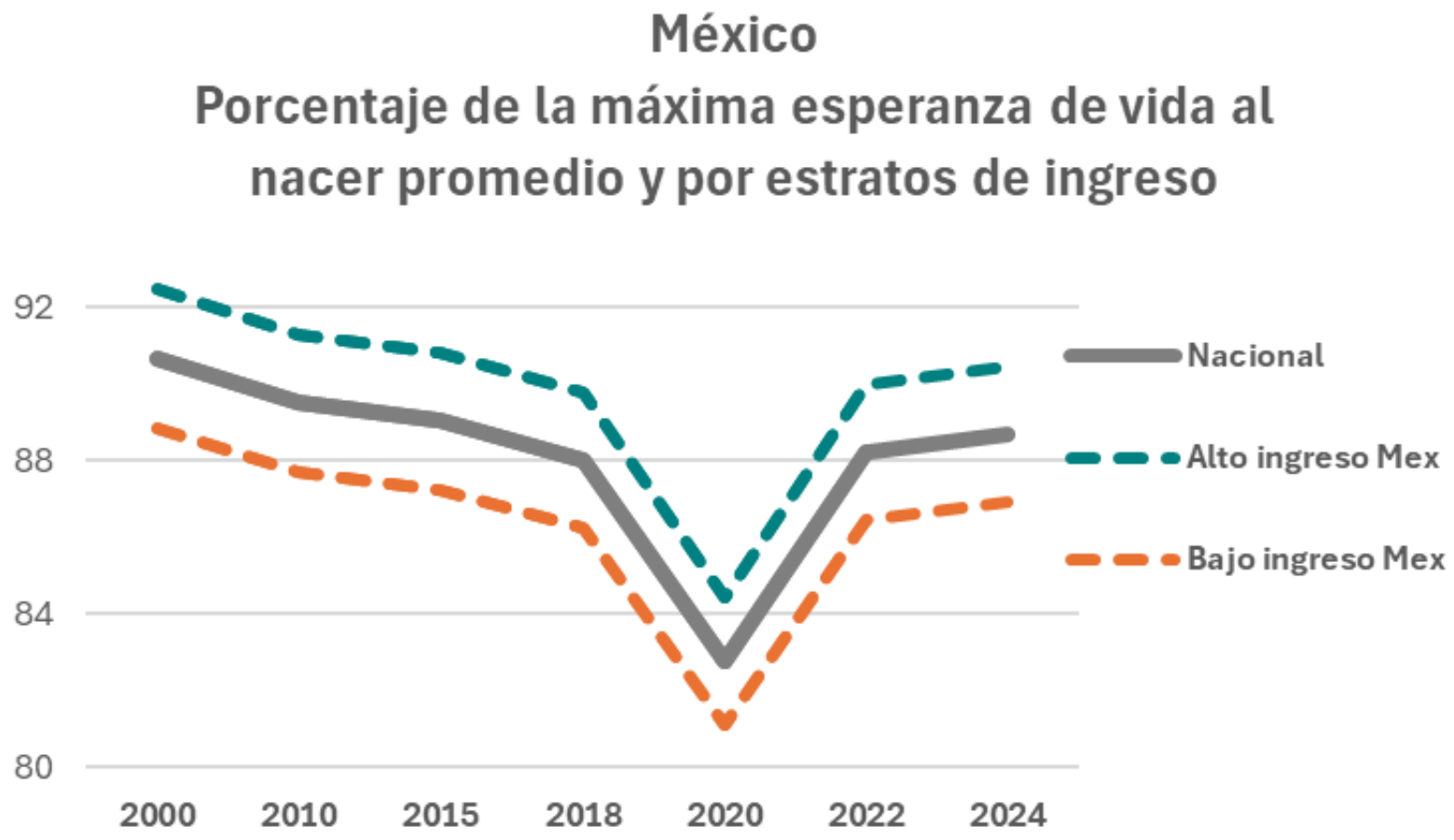


Fuente: UNDP, HDI 2024.

El INDICE DE SALUD SE HA REDUCIDO Y ES DESIGUAL

3% es la caída

del índice de salud en 22 años. La distancia entre los estratos de menores y mayores ingresos es equivalente a tres años



Fuente: CEEY, con datos de CONAPO

EN MÉXICO LAS CONDICIONES DE SALUD PERSISTEN INTERGENERACIONALMENTE

87%

de los mexicanos que nacen en hogares con padres con el menor número de años de vida, no alcanzan los años de vida promedio

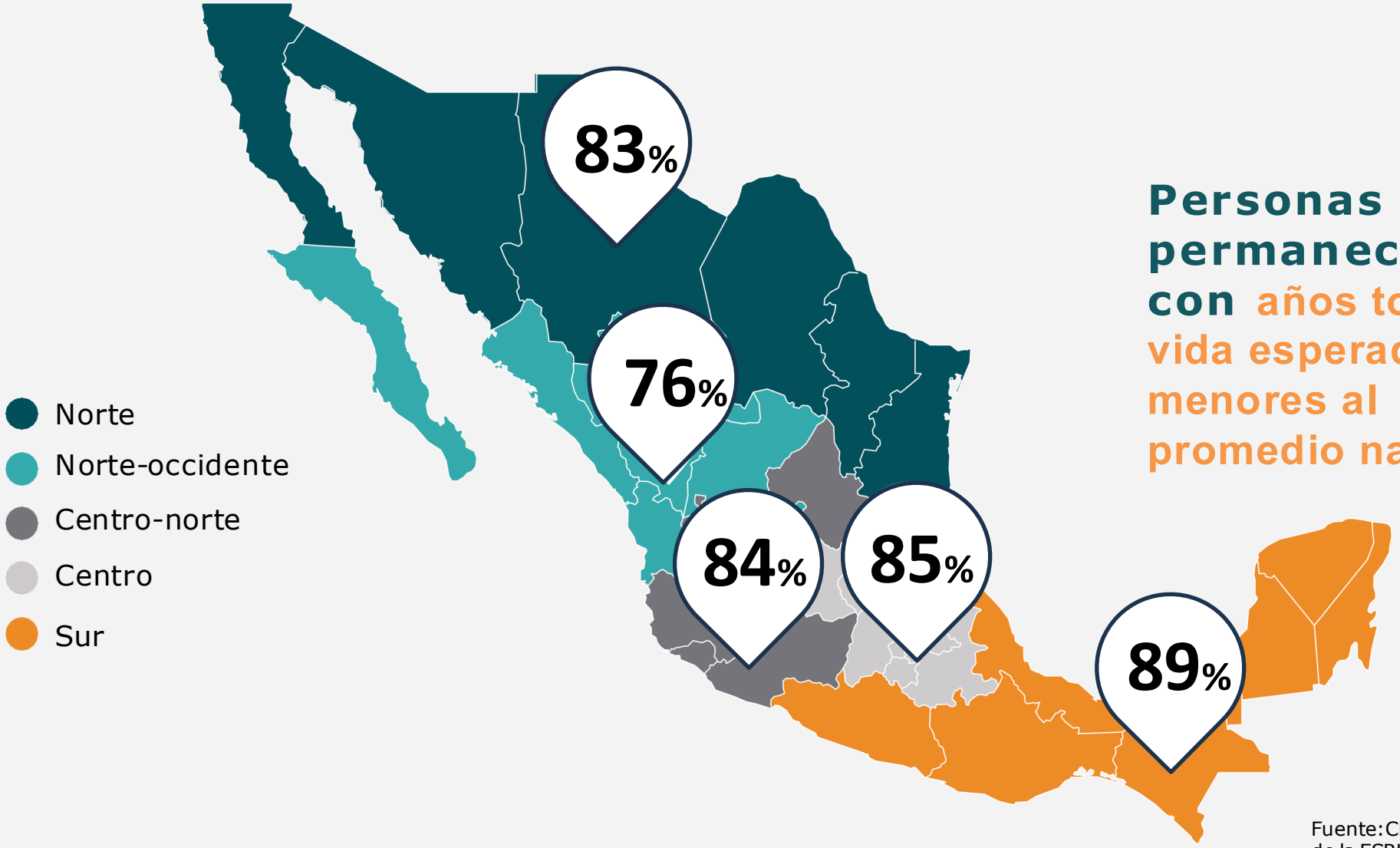
ORIGEN

Personas que nacieron en hogares con los menores años de vida

DESTINO

Fuente: CEEY (2019) con datos de la ESRU-EMOVI 20123

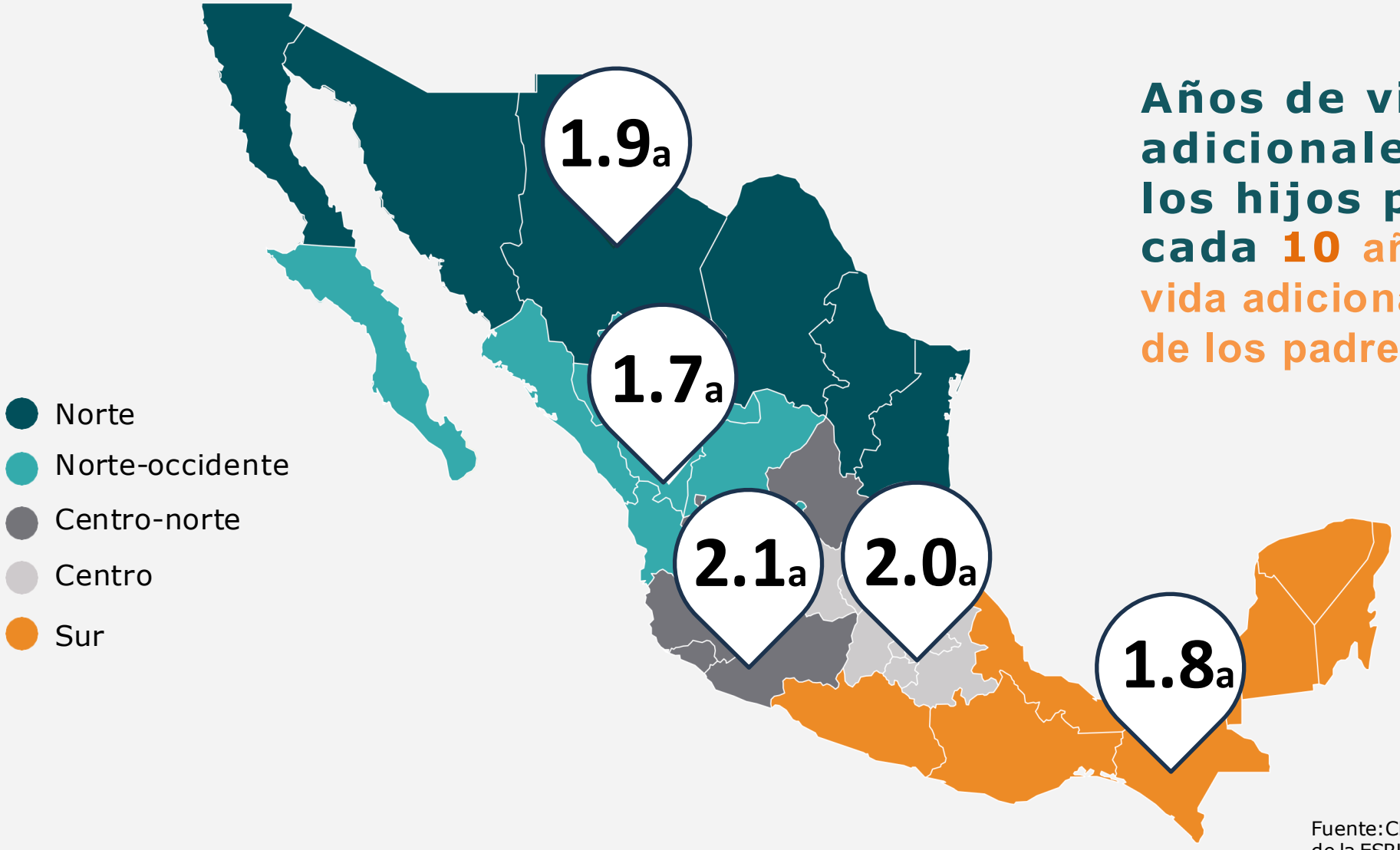
LOS MENORES AÑOS DE VIDA SE PERPETÚAN MÁS EN EL SUR DEL PAÍS



Personas que permanecen con años totales vida esperados menores al promedio nacional

Fuente: CEEY (2019) con datos de la ESRU-EMOVI 2017.

EFECTO DE LA SALUD DE LOS PADRES LA DE LOS HIJOS



Años de vida adicionales de los hijos por cada 10 años de vida adicionales de los padres

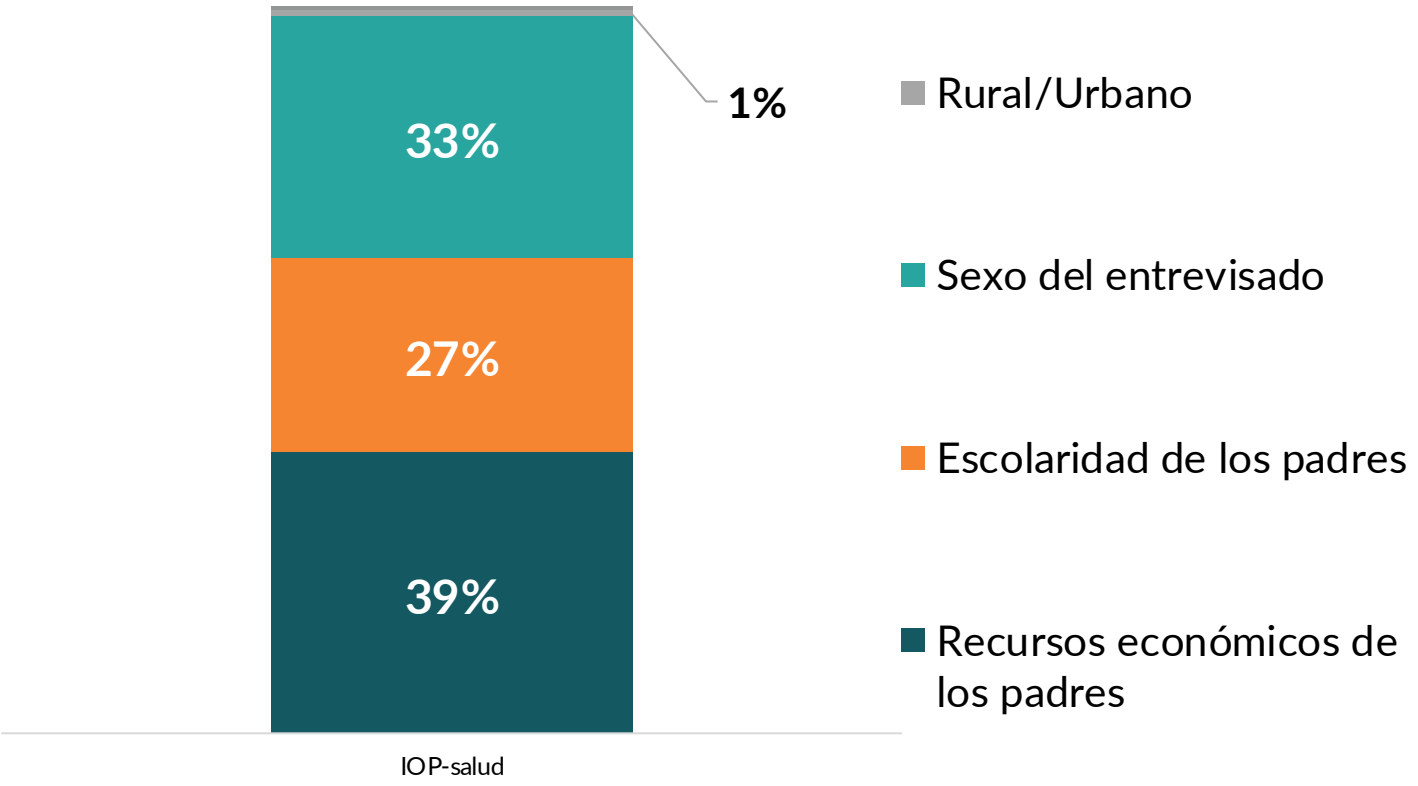
Fuente: CEEY (2019) con datos de la ESRU-EMOVI 2017.

LA DESIGUALDAD EN SALUD PROVIENE DE LA DESIGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Al menos 45%

de la desigualdad en años totales de vida esperados se debe a la desigualdad de oportunidades

COMPONENTES DE LA DESIGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN SALUD



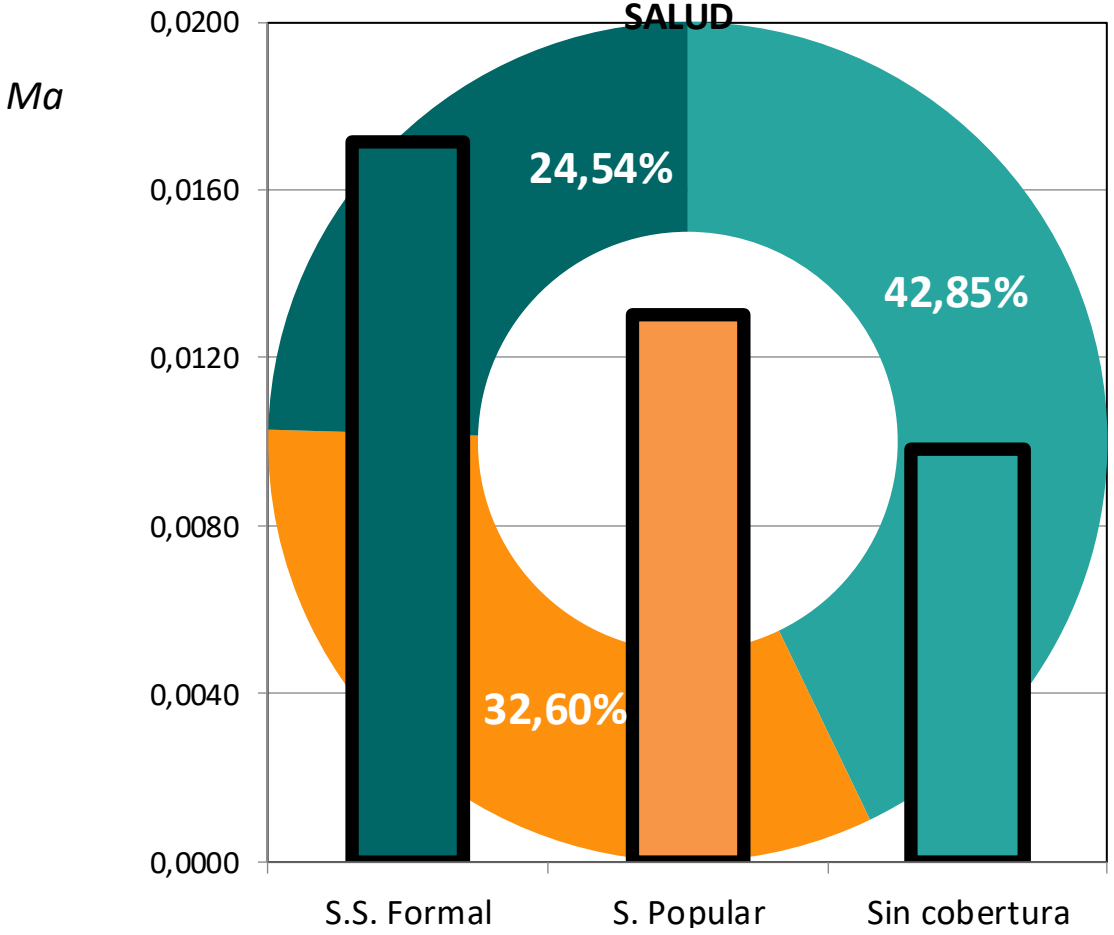
Fuente: CEEY con base en la ESRU-EMOVI 2017.

LA MAYOR MOVILIDAD EN SALUD SE ASOCIÓ A LOS SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRABAJO FORMAL

33%

de la movilidad en salud se asociaba a las personas adscritas al Seguro Popular

INDICES DE MOVILIDAD SOCIAL ASCENDENTE Y CONTRIBUCIONES A LA MOVILIDAD POR TIPO DE ADSCRIPCIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD



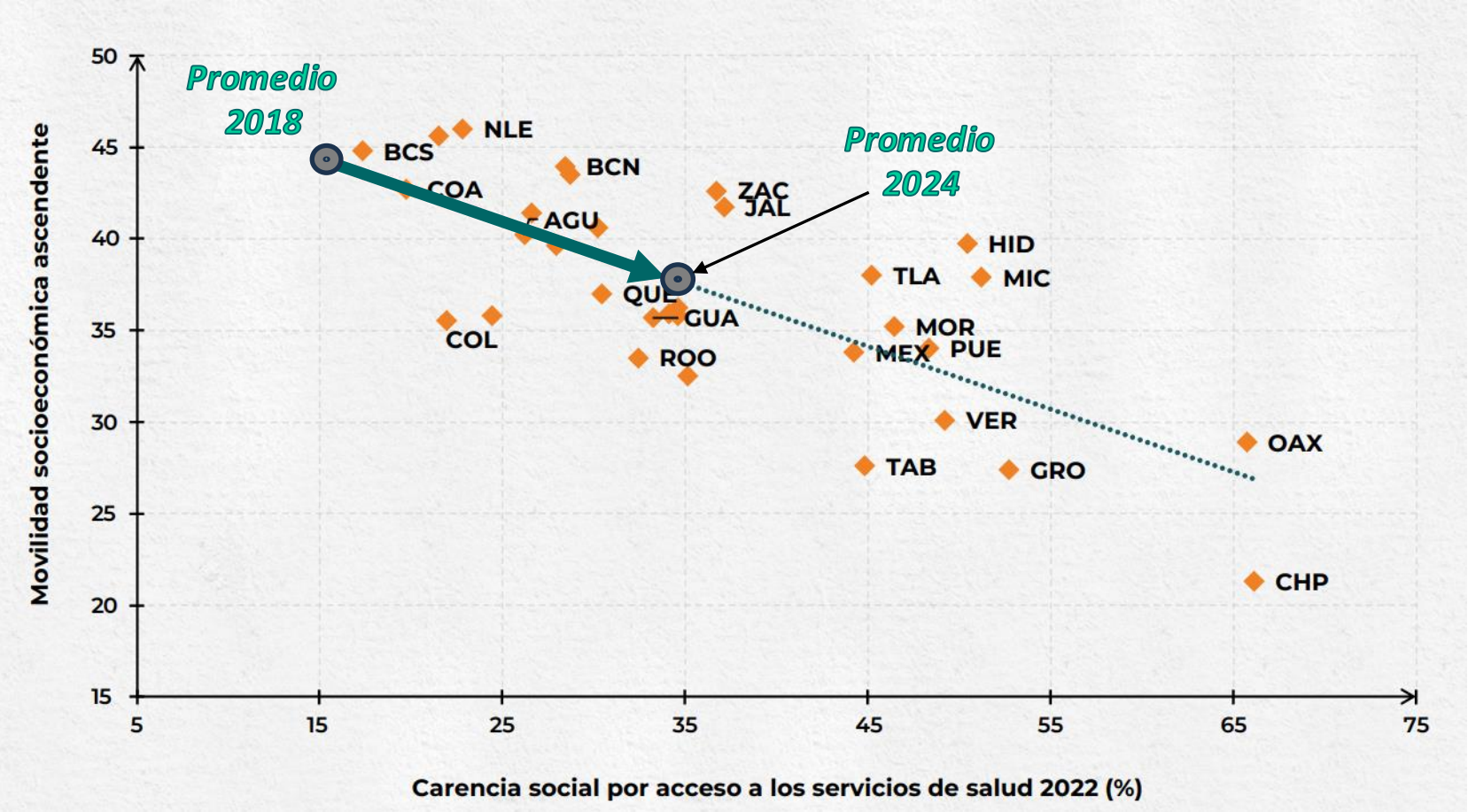
Fuente: CEEY, 2019.

LA CARENCIA DE ACCESO A SERVICIOS DE SALUD REDUCE LA MOVILIDAD SOCIAL

24.4

MILLONES

perdieron su acceso a los servicios de salud de 2018 a 2024 lo que reduciría la movilidad socioeconómica en 18%



Fuente: INEGI-CEEY.

EL SISTEMA DE SALUD: PROBLEMAS Y PROPUESTAS

Subfinanciamiento: El gasto representa 3 % del PIB, cuando lo recomendable es 6 %.

Segmentación: Trato diferenciado a las personas de acuerdo a su estatus laboral.

Fragmentación: Existen múltiples actores que duplican funciones.

- ☑ Financiar el sistema con impuestos generales e incrementar el gasto público en al menos 1.5 puntos del PIB.
- ☑ Integrar los seguros de salud del IMSS con los del IMSS-Bienestar (paso inicial para la integración del sistema).
- ☑ Establecer un pagador único como primer paso para reducir la fragmentación del sistema.

¡GRACIAS!

rodolfodelatorre2025@gmail.com

@equidistar